Boîte à outils sur les maladies rares et développementales v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données pour saisir les phénotypes essentiels associés à la recherche biomédicale sur les maladies rares et développementales (R&D), telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

La boîte à outils de R&D permet de recueillir des données phénotypiques essentielles liées à la recherche, notamment : antécédents de naissance, antécédents de développement neurologique, épilepsie et anomalies systémiques. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation de cette boîte à outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils de R&D se compose de 7 instruments, numérotés de 1 à 7 :

Instrument	**Phénotypes**
1	Parents biologiques et grands-parents
2	Antécédents de naissance du participant
3	Étapes du développement
4	Évaluation du développement neurologique
5	Troubles du développement
6	Dépistage de l'épilepsie
7	Maladies rares

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de le compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (liées notamment à la date de naissance/l'âge et à la grossesse en cours) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cet outil en conjonction avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/AfriGen-D/Phenotype_Collection_Toolkits).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de prélèvement, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes, et ceux-ci sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de

noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Parents biologiques et grands-parents

Cet instrument permet d'enregistrer les liens de consanguinité possibles avec les parents et grands-parents biologiques du participant à la recherche.

Questions	Quel est le degré de parenté (consanguinité) entre les parents biologiques du participant ? **Options de réponse** : Premier degré ; deuxième degré ; troisième degré ; autre degré de parenté ; aucun lien de parenté (Si autre) Précisez tout autre degré de parenté (consanguinité) entre les parents biologiques : Quel est le degré de parenté (consanguinité) entre les grands-parents biologiques maternels du participant ? **Options de réponse** : Premier degré ; deuxième degré ; troisième degré ; autre degré de parenté ; aucun lien de parenté Quel est le degré de parenté (consanguinité) entre les grands-parents biologiques paternels du participant ? **Options de réponse** : Premier degré ; deuxième degré ; troisième degré ; autre degré de parenté ; aucun lien de parenté L'un des parents biologiques de la participante a-t-il déjà subi une fausse couche ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Combien de fausses couches ?

Notes	- de la notion de parenté :
	  - **Premier degré** – comprend les parents, les frères et sœurs et les enfants d'une personne.
	  - **Deuxième degré** – comprend les grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces et demi-frères et sœurs d'une personne.
	  - **Troisième degré** – comprend les arrière-grands-parents, les arrière-petits-enfants, les grands-oncles/tantes et les cousins germains d'une personne.
	- **La perte de grossesse** désigne une complication fréquente de la grossesse, entraînant un avortement spontané avant que le fœtus n'ait atteint le stade de viabilité.

	- Les personnes menant les entretiens doivent faire preuve de sensibilité envers la culture et la religion du participant et être conscientes que certains participants peuvent être réticents à répondre honnêtement à ces questions. - Les participants peuvent être assurés que leurs réponses resteront confidentielles.

Instrument 2 : Antécédents de naissance du participant

Cet instrument permet la collecte rétrospective d'informations exhaustives relatives aux antécédents de naissance du participant , c'est-à-dire des informations sur l'accouchement et l'état de santé à la naissance, généralement recueillies dans le cadre des antécédents médicaux.

<table>
<tr><td>Questions</td><td>La mère biologique de la participante a-t-elle souffert de maladies pendant sa grossesse ?
Options de réponse :
Oui ; Non
(Si oui) Précisez le type de maladie(s) survenue(s) pendant la grossesse :
Options de réponse :
Hypertension chronique ; diabète de type 1 ; diabète de type 2 ; épilepsie ; diabète gestationnel ; VIH/SIDA ; hypertension gravidique ; dysfonctionnement thyroïdien ; autres
(Si autre) Précisez le(s) autre(s) type(s) de maladie(s) survenue(s) pendant la grossesse :</td></tr>
<tr><td>Notes</td><td>- Description des maladies (spécifiques à la grossesse de la participante à la recherche inscrite) :
<table>
<tr><td>Maladie</td><td>Description</td></tr>
<tr><td>Diabète gestationnel</td><td>Intolérance aux glucides diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse.</td></tr>
<tr><td>Diabète sucré de type 1</td><td>Le diabète de type 1 est une maladie chronique caractérisée par une production insuffisante ou nulle d'insuline par le pancréas. Il se manifeste par l'apparition soudaine d'une hyperglycémie sévère pouvant évoluer rapidement vers une acidocétose diabétique en l'absence de traitement par insuline.</td></tr>
<tr><td>Diabète sucré de type 2</td><td>Un type de diabète sucré initialement caractérisé par une résistance à l'insuline et une hyperinsulinémie, puis par une intolérance au glucose et une hyperglycémie.</td></tr>
<tr><td>Hypertension gravidique</td><td>Une élévation de la pression artérielle après 20 semaines de gestation en l'absence de protéinurie ou de signes systémiques tels que thrombocytopénie, altération de la fonction hépatique, insuffisance rénale progressive, œdème pulmonaire ou apparition de troubles cérébraux ou visuels.</td></tr>
<tr><td>Hypertension chronique</td><td>Pression artérielle systémique constamment élevée. D'après plusieurs mesures (détermination de la pression artérielle), l'hypertension est actuellement définie comme une pression</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	systolique constamment supérieure à 140 mmHg ou une pression diastolique constamment supérieure ou égale à 90 mmHg.
Épilepsie	Un trouble dans lequel l'activité cérébrale devient anormale, provoquant des crises d'épilepsie ou des périodes de comportements inhabituels, de sensations anormales et parfois de perte de conscience.
Dysfonctionnement thyroïdien	Une affection médicale qui empêche la thyroïde de produire la quantité appropriée d'hormones thyroïdiennes.
VIH/SIDA	Syndrome résultant d'un déficit immunitaire cellulaire acquis causé par le VIH. Il se caractérise par une diminution du nombre de lymphocytes T dans le sang périphérique et les ganglions lymphatiques.

Questions	La mère biologique du participant a-t-elle reçu des vaccins pendant sa grossesse ? La mère du participant a-t-elle pris des médicaments pendant sa grossesse ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le(s) type(s) de médicament(s) utilisé(s) pendant la grossesse : **Options de réponse** : Anticonvulsivants ; Antidépresseurs ; Anxiolytiques ; Antibiotiques ; Antihypertenseurs ; Antimicrobiens ; Antirétroviraux ; Antithyroïdiens ; Anti-inflammatoires ; Autres (Si autre) Précisez le type de médicament utilisé pendant la grossesse :

Notes	- Description des médicaments :
	  - **Antirétroviraux : médicaments utilisés pour traiter les** infections à rétrovirus, tels que les médicaments utilisés pour traiter le VIH/SIDA.
	  - **Anticonvulsivants :** médicaments utilisés dans le traitement des crises d'épilepsie.
	  - **Antidépresseurs** : médicaments utilisés pour traiter le trouble dépressif majeur , certains troubles anxieux, certaines douleurs chroniques et pour aider à gérer certaines dépendances.
	  - **Anxiolytiques** : médicaments qui réduisent l'anxiété.
	  - **Antihypertenseurs** : médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension.
	  - **Antibiotiques** : médicaments utilisés pour combattre les infections causées par des bactéries.
	  - **Antimicrobiens** : médicaments utilisés pour traiter une infection microbienne , notamment les antibiotiques, les antifongiques, les antiprotozoaires et les antiviraux.
	  - **Antithyroïdiens** : médicaments qui inhibent la production d'hormones thyroïdiennes.
	  - **Anti-inflammatoire** : médicament qui réduit la douleur, diminue l'inflammation, fait baisser la fièvre et prévient la formation de caillots sanguins.

Questions	La mère biologique du participant a-t-elle fumé des cigarettes pendant sa grossesse ? La mère biologique de la participante a-t-elle consommé de l'alcool pendant sa

	grossesse ? La mère biologique du participant a-t-elle consommé des substances illicites pendant sa grossesse ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les substances utilisées pendant la grossesse : **Options de réponse** : Sédatifs ou tranquillisants ; Analgésiques ; Marijuana ; Cocaïne ou crack ; Stimulants ; Drogues de synthèse ; Hallucinogènes ; Inhalants ou solvants ; Héroïne ; Autre (Si autre) Précisez les autres substances utilisées pendant la grossesse :
Notes	- Pour la description des substances illicites, voir **Phénotypes de base** .
Questions	La mère biologique de la participante a-t-elle été exposée à des toxines environnementales ou professionnelles pendant sa grossesse ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les toxines environnementales ou professionnelles auxquelles vous avez été exposée pendant votre grossesse : **Options de réponse** : Arsenic ; plomb ; mercure ; nickel ; peintures à l'huile ; diluants pour peintures organiques ; pesticides ; solvants ; autres (Si autre) Précisez les autres toxines environnementales ou professionnelles auxquelles vous avez été exposée pendant votre grossesse :

Notes	- Description des toxines environnementales :
	  - **Plomb, mercure, arsenic, nickel** : un groupe de métaux lourds toxiques qui peuvent affecter la santé humaine.
	  - **Peintures à base d'huile** : La peinture à base d'huile contient de l'huile naturelle ou synthétique comme base et s'est répandue en raison de son prix plus bas et de sa plus grande résistance.
	  - **Diluants à peinture** : tous les solvants utilisés pour diluer les peintures à base d'huile ou pour nettoyer après leur utilisation, y compris l'essence minérale, l'acétone, la térébenthine, le diméthylformamide, etc.
	  - **Pesticides** : agents utilisés pour contrôler, repousser ou tuer les organismes indésirables.
	  - **Solvants organiques** : substances à base de carbone capables de dissoudre ou de disperser d'autres substances, notamment le benzène, le tétrachlorure de carbone et le trichloroéthylène.

Questions	La mère biologique du participant a-t-elle subi des radiographies médicales pendant sa grossesse ? La mère biologique des participants a-t-elle subi un scanner pendant sa grossesse ? La mère biologique du participant a-t-elle subi des échographies pendant sa grossesse ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez les résultats de l'échographie : **Options de réponse** : Anomalies ou irrégularités détectées ; Aucune anomalie ou irrégularité détectée

	(Si des anomalies ou des irrégularités sont détectées) Précisez les résultats de l'échographie :

Notes	- Définitions pertinentes :
	  - **Rayons X** : faible rayonnement utilisé pour créer des images de l'intérieur du corps.
	  - **Radiographies dentaires** : images des dents créées par irradiation.
	  - **Scanner CT** : technique d'imagerie médicale utilisée pour produire des images en coupe d'un corps, permettant à l'utilisateur de voir l'intérieur du corps sans incision.
	  - **Échographie** : un examen médical qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour capturer des images en direct de l'intérieur du corps.

Questions	La mère biologique de la participante a-t-elle présenté des saignements pendant sa grossesse ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le trimestre durant lequel les saignements sont survenus : **Options de réponse** : 1er trimestre ; 2e trimestre ; 3e trimestre Quel était l'âge gestationnel du participant à la naissance (en semaines) ? Des soins néonatals intensifs/spéciaux étaient-ils nécessaires ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Combien de jours ont été passés en soins intensifs/néonatals ? (Si oui) Quel était le motif des soins intensifs ? **Options de réponse** : cardiaques ; Difficultés d'alimentation ; Encéphalopathie hypoxique -ischémique Sepsis néonatal Prématurité Difficultés respiratoires Autre (Si autre) Précisez l'autre raison des soins intensifs :

Notes	- Descriptions des trimestres :
	  - **1er trimestre** : Période de grossesse qui s'étend du premier jour des dernières règles à la 12e semaine.
	  - **2e trimestre** : Période de grossesse qui s'étend de la 13e à la 27e semaine.
	  - **3e trimestre** : Période de grossesse qui s'étend de la 28e semaine jusqu'à l'accouchement.
	- **Âge gestationnel** : mesure de l'âge d'une grossesse calculée à partir du début des dernières règles de la femme.
	- **Néonatal** : désigne les nourrissons depuis la période suivant immédiatement la naissance et se poursuivant pendant les 28 premiers jours de vie extra-utérine.
	- Description des complications néonatales :
	  - **Encéphalopathie hypoxique-ischémique** : lésion cérébrale ischémique dans laquelle le cerveau entier est privé d'oxygène.
	  - **Prématurité** : état d'un nourrisson né viable avant 37 semaines de gestation.
	  - **Sepsis néonatal** : affection infectieuse des nouveau-nés, caractérisée par une réponse inflammatoire systémique le plus souvent causée par des

	bactéries. - **Difficultés d'alimentation** : altération de la capacité à s'alimenter liée à des problèmes pour rassembler la nourriture et se préparer à la sucer, la mâcher ou l'avaler. - **Anomalies cardiaques** : Malformations congénitales du cœur. - **Difficultés respiratoires :** respiration difficile ou laborieuse

Instrument 3 : Étapes du développement

Cet instrument permet d'enregistrer les étapes clés du développement d'un participant à la recherche.

Questions	**Étapes importantes du développement moteur global :** Le participant est-il capable de s'asseoir sans soutien ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant s'est-il assis pour la première fois sans soutien ? Le participant est-il capable de ramper ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant a -t-il commencé à ramper ? Le participant est-il capable de marcher sans aide ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant a-t-il marché pour la première fois sans aide ?
Notes	- **Motricité globale** : les habiletés qui nécessitent un mouvement de l'ensemble du corps et qui impliquent les grands muscles (stabilisateurs du tronc) pour accomplir les fonctions quotidiennes
Questions	**Étapes clés de la motricité fine** Le participant est-il capable de s'habiller seul ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant pouvait-il s'habiller seul ?
Notes	- **Motricité fine** : les compétences qui nécessitent la coordination des petits muscles en mouvement avec les yeux, impliquant généralement la synchronisation des mains et des doigts.
Questions	**Étapes sociales et linguistiques** Le participant est-il capable de sourire lorsqu'on le lui demande ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant a-t-il souri lorsqu'on le lui a demandé ? Le participant est-il capable de s'exprimer verbalement ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant À quel âge le participant a-t-il prononcé ses premiers mots ? Le discours du participant est-il intelligible (un locuteur étranger, par exemple quelqu'un qui ne vit pas avec le participant, pourrait-il le comprendre) ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant

Instrument 4 : Évaluation du développement neurologique

Cet outil permet de recueillir des informations relatives aux antécédents neurodéveloppementaux d'un participant. Comme il implique une évaluation clinique, il doit être réalisé par un spécialiste en soins de santé neurodéveloppementaux qualifié ou les informations doivent être obtenues auprès de ce dernier.

Questions	Le participant a-t-il subi une évaluation neurodéveloppementale par un clinicien ? **Options de réponse :** Oui ; Non (Si oui) Une évaluation du développement neurologique a-t-elle été réalisée en fonction de l'âge ? (Si oui) Quel a été le résultat de l'évaluation neurodéveloppementale du DI/DD ? **Options de réponse** : Pas de pièce d'identité/ DD ; ID/ DD légère ; ID/ DD modéré ; Déficience intellectuelle/trouble du développement sévère Le participant a-t-il déjà redoublé une année scolaire ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Jamais fréquenté l'école (Si oui) Combien d'années supplémentaires le participant a-t-il passées à l'école ?
Notes	- **ID :** Déficience intellectuelle - **DD :** Trouble du développement
Questions	Le participant présente-t-il l'un des comportements anormaux suivants ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si autre) Précisez le ou les comportements anormaux : Comportements anormaux : Agression Comportement autistique Hyperactivité Comportement répétitif Comportement rituel automutilation comportement Autres comportements anormaux

Notes	- des comportements :
	  - **Agressivité** : Un type de comportement dans l'intention de causer un préjudice physique ou mental.
	  - **Comportements répétitifs** : comportements anormaux caractérisés par la répétition, la rigidité, l'inadéquation et le manque d'adaptabilité.

	- **Comportements rituels** : également appelés comportements obsessionnels , exemples : routines physiques, besoin de corriger ce qui n'est pas conforme à leur version de ce qui est correct, respect d'un horaire strict, etc. - **Hyperactivité** : anormalement ou extrêmement actif. - **Comportements autistiques** : mouvements corporels répétitifs (battements de mains, balancements, rotations) ; agitation constante. Attachement obsessionnel à des objets inhabituels (élastiques, clés, interrupteurs). - **automutilation Comportements** : comportements dans lesquels une personne se blesse délibérément physiquement.

Instrument 5 : Troubles du développement

Cet instrument permet de recueillir des informations relatives aux antécédents de troubles du développement d'un participant.

Questions	Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de syndrome d'alcoolisation fœtale ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si oui) À quel âge ? Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble génétique du développement ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si oui) À quel âge ? (Si oui) Précisez le trouble génétique du développement : **Options de réponse :** Syndrome de Down ; Syndrome de l'X fragile ; Autre (Si autre) Précisez l'autre trouble génétique : Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si oui) À quel âge ? Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ? Trouble (TDAH) ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si oui) À quel âge ? Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble d'apprentissage ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant (Si oui) À quel âge ? (Si oui) Précisez TOUS les troubles d'apprentissage diagnostiqués : **Options de réponse :** Mathématiques (dyscalulie) ; Lecture (dyslexie) ; Écriture (dysgraphie) ; Troubles du traitement de l'information Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble du langage ou de la parole ? **Options de réponse :** Oui ; Non ; Plus maintenant

Notes

- Description des maladies :

Troubles d'apprentissage	Description
Syndrome d'alcoolisation fœtale	Ce trouble, causé par une exposition prénatale à la consommation d'alcool par la mère, entraîne chez l'enfant divers déficits comportementaux, cognitifs et neurologiques. Il se caractérise par des problèmes de croissance physique, une dysmorphie faciale et divers troubles psychoneurologiques.
syndrome de Down	Le syndrome de Down est une dysgénésie chromosomique résultant d'une triplication ou d'une translocation du chromosome 21. Il touche environ 1 naissance vivante sur 700. Les anomalies varient d'une personne à l'autre et peuvent inclure un retard de développement mental, un retard de croissance, un visage plat et hypoplasique avec un nez court, des épicanthus marqués, de petites oreilles bas implantées avec un anti-hélix proéminent, une langue fissurée et épaissie, une hyperlaxité ligamentaire, une dysplasie pelvienne, des mains et des pieds larges, des doigts courts, un pli palmaire transverse, des opacités lenticulaires et une cardiopathie.
Syndrome de l'X fragile	Le syndrome de l'X fragile est un syndrome génétique causé par des mutations du gène FMR1, responsable de l'expression de la protéine FMR1 (protéine 1 du retard mental lié à l'X fragile). Cette protéine participe au développement neuronal. Ce syndrome se manifeste par des déficiences mentales, émotionnelles, comportementales, physiques et des troubles d'apprentissage.
Maladie génétique	Un trouble dont l'étiologie implique une anomalie dans la séquence nucléotidique du génome d'un organisme.
Trouble du spectre autistique	Ce trouble, qui débute dans l'enfance, se caractérise par un développement social et communicationnel fortement anormal ou altéré, ainsi que par un répertoire d'activités et d'intérêts très restreint. Ses manifestations varient considérablement selon le stade de développement et l'âge de l'individu.
TDAH	Le TDAH est un trouble qui peut entraîner une hyperactivité et une impulsivité excessives. Les personnes atteintes de TDAH peuvent également avoir des difficultés à se concentrer sur une seule tâche ou à rester assises longtemps.
Dyslexie	Un trouble qui se caractérise par des difficultés de lecture dues à des problèmes d'identification des sons de la parole et d'apprentissage de leur correspondance avec les lettres et les mots (décodage).
Dyscalculie	Un handicap qui altère la capacité d'une personne à apprendre les concepts liés aux nombres, à effectuer des calculs mathématiques précis, à raisonner et à résoudre des problèmes, et à maîtriser d'autres compétences mathématiques de base.

	Dysgraphie	Un trouble de l'expression écrite qui altère la capacité d'écriture et la motricité fine.
	Déficits de traitement	Les difficultés de traitement de l'information sensorielle sont des problèmes liés à sa reconnaissance et à son interprétation. Les deux domaines les plus fréquemment touchés par ces difficultés, associés aux troubles d'apprentissage, concernent la perception visuelle et auditive.

Instrument 6 : Test de dépistage de l'épilepsie

Cet instrument permet la collecte rétrospective d'informations relatives aux antécédents de crises et d'épilepsie d'un participant.

Questions	[Le participant a-t-il déjà eu une crise d'épilepsie ou une convulsion provoquée par une forte fièvre ? Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de trouble convulsif ou d'épilepsie ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- **L'épilepsie** est une maladie cérébrale caractérisée par la survenue d'au moins deux crises non provoquées, résultant d'une anomalie épileptogène persistante du cerveau capable de générer spontanément une activité paroxystique et se manifestant généralement par des épisodes brefs et soudains d'altération ou de diminution de la conscience, de mouvements involontaires ou de convulsions.
Questions	[(Si non) Le participant a-t-il déjà vécu... - Une crise, une convulsion, un accès de colère ou une maladresse, quelles que soient les circonstances ? - Mouvements incontrôlés d'une partie ou de la totalité du corps, tels que des contractions, des secousses, des tremblements ou un relâchement musculaire ? - Un changement inexpliqué de l'état mental ou du niveau de conscience ; ou un épisode de « déconnexion » incontrôlable ? - Vous avez tendance à rêvasser ou à fixer le vide plus souvent que vos pairs ? - Des mouvements corporels ou des sensations inhabituelles lors d'une exposition à des lumières stroboscopiques, aux jeux vidéo, aux lumières clignotantes ou à l'éblouissement du soleil ? - Des mouvements saccadés ou une maladresse incontrôlables, comme laisser tomber des objets, peu de temps après le réveil ? - D'autres types de sorts inhabituels répétés ? **Options de réponse** : Oui ; Non

Notes	- Les questions ci-dessus portent spécifiquement sur les symptômes d'épilepsie chez les participants et doivent être recueillies auprès des participants avec et sans épilepsie.

Instrument 7 : Maladies rares

Cet instrument permet le recueil autodéclaré du diagnostic de maladie rare d'un participant.

Questions	Le participant a-t-il déjà reçu un diagnostic de maladie rare ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez la maladie rare : (Si oui) Le participant suit-il un traitement pour cette maladie rare ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le traitement que suit le participant pour une maladie rare :

Notes	- Une **maladie rare** désigne toute maladie qui touche un faible pourcentage de la population étudiée .
	- **Exemples de maladies rares :**
	  - Fibrose kystique.
	  - dystrophie musculaire
	  - Spina bifida
	  - Hémophilie
	  - Sclérose en plaques
	  - Narcolepsie

Abréviations

TDAH : Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité
SIDA : Syndrome d'immunodéficience acquise
Scanner : tomodensitométrie
DD : Déficience intellectuelle
VIH : Virus de l'immunodéficience humaine
ID : Déficience intellectuelle

Administration

Mode d'administration

	Instruments						
	1	2	3	4	5	6	7
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X		X	X	X
évaluation clinique			X	X			

Évaluation par bioessai/en laboratoire							

Étape de la vie

	Instruments						
	1	2	3	4	5	6	7
Nourrisson (0 - 12 mois)	X	X	X		X		X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)	X	X	X		X		X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X	X	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1, 2, 3, 5, 6 et 7 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible. Les informations peuvent également être recueillies ou vérifiées à partir des dossiers hospitaliers et/ou des dossiers patients. Les informations de **l'instrument 4** doivent provenir d'une évaluation clinique réalisée par un professionnel de santé qualifié et formé. Cette exigence peut également s'appliquer à **l'instrument 3** .

Références

La boîte à outils de R&D s'appuie sur plusieurs normes existantes et est alignée sur celles-ci afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Formulaires de rapport de cas H3Africa DDD-Africa
2. Formulaires de rapport de cas du groupe de travail sur les maladies rares H3Africa
3. Instrument - Dépistage de l'épilepsie - Adulte (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/130401)
4. Instrument - Dépistage de l'épilepsie - Enfant/Proxy (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/130402)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Emma Wiener
Judit Kumuthini
Lyndon Zass
Nihad Alsayed

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .